REVISE PARA PROVA · SEU RESUMO EM UMA ÚNICA FOLHA

Anemias Carenciais

Anemia ferropriva e anemia megaloblástica (vitamina B12 e folato) em uma página

MAIS COBRADO

- **1º Ferritina < 30** confirma (protocolo BR)
- **2º Ferropriva × inflamação × talassemia**
- **3º B12**: neuro e nunca folato isolado
- **4º Ferropenia no homem** = trato digestivo

1 Definir e classificar

Anemia (OMS/MS): homem < 13 · mulher < 12 · gestante < 11 · criança < 11 g/dL. Crônica pode ser pouco sintomática até Hb 7–8 (↑ 2,3-DPG, ↑ débito, redistribuição).

Índice reticulocítico < 2 = produção/maturação (carenciais) · > 2,5 = hemólise. **VCM** < 80 micro · 80–100 normo · > 100 macro. **RDW** alto na ferropriva, normal no traço talassêmico.

2 Anemia ferropriva

a causa mais comum de anemia

Absorção no **duodeno** (DMT-1), saída pela **ferroportina**. **Hepcidina** degrada a ferroportina: **cai** na falta de ferro e **sobe** na inflamação. Ordem da queda: **ferritina** → ferro/saturação → Hb e microcitose.

Causas: perda (menstruação, TGI, parasitose), demanda (gestação, crescimento), dieta, má absorção (bariátrica, celíaca, IBP). **Clínica:** coiloníquia, queilite, **pica/pagofagia**, Plummer-Vinson.

	Ferropriva	Inflamação	Traço talassêmico
Ferritina	**< 30** (< 15 grave)	Normal/alta (≥ 100)	50–300
TIBC	**Alta** (> 360)	**Baixa** (< 300)	Normal
Saturação	< 10–20%	10–20%	30–80%
RDW	Alto	Normal ou alto	**Normal**
Eletroforese	Normal	Normal	**HbA2 alta** (β)

Com inflamação: saturação < 20% + ferritina **30–100** = ferropenia associada; ferritina ≥ 100 + PCR alta = só inflamação.

Tratar: sulfato ferroso longe das refeições · homem 120 mg/dia, mulher e gestante 100–200 mg (+ fólico 400 µg), criança 3–6 mg/kg · **mínimo 90 dias**, até ferritina ≥ 30. Reticulócitos sobem do **3º ao 5º dia** (pico 8–10); Hb ≥ 2 g/dL em 3–4 semanas. **IV**: intolerância, refratária em 8 semanas, bariátrica, DII, diálise. Transfusão só se instável.

3 Anemia megaloblástica

defeito na síntese de DNA

Sem B12, o folato fica "preso" (armadilha do folato). **Ácido metilmalônico sobe só na falta de B12**; homocisteína sobe nas duas. Eritropoese ineficaz: **LDH e BI altas com reticulócitos baixos**; pode haver pancitopenia.

B12: anemia perniciosa (anti-FI específico; anticélula parietal sensível), gastrectomia, íleo, **veganos**, metformina e IBP somam. Reserva dura 3–4 anos. **Folato:** álcool, gestação, hemólise, metotrexato; reserva 3–4 meses.

CLÍNICA E EXAMES

Glossite, icterícia leve. **Só a B12 lesa o nervo:** parestesias, perda vibratória, Romberg +, degeneração combinada subaguda. Macro-ovalócitos, **neutrófilos hipersegmentados**. B12 < 200 pg/mL (< 100 típico).

TRATAR

B12 1.000 µg IM (ataque ~6 doses) → mensal, vitalício se causa permanente; VO 1.000–2.000 µg/dia também funciona. **Ácido fólico 5 mg/dia por 4 meses**. Gestação 400 µg (5 mg se DTN prévio). Monitorar potássio.

Não confunda na prova

Os distratores que mais derrubam

1. **Ferropenia em homem ou pós-menopausa** = sangramento digestivo até prova em contrário: EDA e colonoscopia.
2. **Ferritina é de fase aguda:** pode vir "normal" na inflamação e esconder a falta de ferro.
3. **Inflamação** tem TIBC baixa; ferropriva tem TIBC alta.
4. **Traço talassêmico** tem RDW normal e ferro normal: não dê ferro.
5. **Doador frequente:** Hb quase normal com ferritina baixa.
6. **Plaquetose** na ferropenia é reativa, não é doença da medula.
7. **Falha do ferro oral:** adesão, perda que continua, má absorção, diagnóstico errado.
8. **VCM "normal" na gestante** pode ser ferro + folato juntos; o RDW alto denuncia.
9. **Nunca ácido fólico isolado** sem excluir ou tratar a B12: a lesão neurológica progride.
10. **Neurológico pode vir sem anemia** e pode ficar irreversível.
11. **Anemia perniciosa:** a via oral pode falhar; reposição IM e EDA (risco de câncer gástrico).
12. **LDH alta na megaloblástica** não é hemólise periférica: é eritropoese ineficaz.
13. **Choque hipovolêmico:** Hb pode estar normal nas primeiras horas; resistência vascular alta.
14. **Anemia crônica grave:** IC de alto débito, pele quente, resistência vascular baixa.

Contas e cortes

Saturação (IST) = ferro × 100 ÷ TIBC · < 20% = baixa

Ferritina: < 30 confirma · < 15 grave (protocolo BR)

VCM < 80 · 80–100 · > 100 fL

Ferro IV (Harrison) = peso × 2,3 × (15 − Hb) + 500 a 1.000 mg